Dönem 3 Kurul 1 Çıkmış Sorular — 2026-2027

Öğrencilerin hatırladıklarından derlendi (24.10.2026): derleme PDF'i + "Konu çalışma grubu" tartışması (23.10 10:00 – 24.10 15:25). Grupta numarası yazılan sorular kendi numarasında; diğerleri dersin boş numaralarına yerleştirildi ve "yeri tahmini" diye işaretlendi. Yalnız konusu hatırlanan sorular "Şıklar toplanmadı" diye, hiç bilinmeyenler "toplanmadı" diye gösterilir. Cevaplar kontrol edildi; tartışmalı olanlar soru altında not edildi.

Tıbbi Genetik · sınavda 1–12 · toplanan 12/12

1. Aşağıdakilerden hangisi bir minör anomali örneği değildir? (yeri tahmini)
A) Epikantus katlantısı
B) Düşük kulak
C) Clinodactyly (serçe parmağın içe kıvrılması)
D) Yarık damak
E) Tek palmar çizgi (Simian çizgisi)

2. Bebeğin kedi miyavlamasına benzer ağlaması, mikrosefali ve hipotoni ile karakterize olan ve 5. kromozomun kısa kolundaki delesyon (5p-) sonucu gelişen sendrom aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cri du Chat sendromu
B) Wolf-Hirschhorn sendromu
C) Down sendromu
D) Patau sendromu
E) Edwards sendromu

3. Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) endikasyonları değerlendirildiğinde, aşağıdaki durumlardan hangisinde PGT yapılmasına gerek yoktur? (yeri tahmini)
A) İleri anne yaşı
B) Tekrarlayan tüp bebek (IVF) başarısızlıkları
C) Çiftlerden birinde dengeli kromozomal translokasyon varlığı
D) Fetal Down sendromu taramasında ikili testin düşük riskli çıkması
E) Tek gen hastalığı taşıyıcısı çiftler

4. Ultrasonografide ense saydamlığı (NT) artışı saptanan bir fetüste, sitogenetik incelemede aşağıdaki karyotiplerden hangisinin görülmesi beklenmez?
A) Down sendromu
B) Edwards sendromu
C) Patau sendromu
D) Klinefelter sendromu
E) Turner sendromu

5. 46, XX karyotipine sahip bir yenidoğanda 21-hidroksilaz enzim eksikliği saptanmıştır. Bu klinik tablo aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır? (yeri tahmini)
A) Konjenital Adrenal Hiperplazi (KAH)
B) Androjen Duyarsızlığı Sendromu
C) 5-alfa Redüktaz Eksikliği
D) Swyer Sendromu
E) Turner Sendromu

6. Kadın cinsiyet organlarının ve overlerin embriyonik gelişim basamaklarında anahtar rol oynayan ve Wnt/β-katenin yolaklarını aktive eden genler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
A) SRY ve SOX9
B) WNT4 ve DAX1
C) WT1 ve SF1
D) AMH ve AR
E) AZF ve KDM5D

7. BRCA1 veya BRCA2 gen mutasyonu taşıyan over ve meme kanserli hastalarda homolog rekombinasyon DNA tamir mekanizması bozuktur. Bu hastalarda sentetik ölümcül etki oluşturarak tedavide kullanılan hedefe yönelik ilaç grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) PARP inhibitörleri
B) Tirozin kinaz inhibitörleri
C) EGFR monoklonal antikorları
D) Proteazom inhibitörleri
E) mTOR inhibitörleri

8. Serumda Alfa-Fetoprotein (AFP), Beta-hCG ve Laktat Dehidrojenaz (LDH) tümör belirteçlerinin birlikte yükselmesi aşağıdaki kanser türlerinden hangisinin tanısı ve takibi için karakteristiktir?

A) Mesane kanseri
B) Prostat kanseri
C) Over epitelyal kanseri
D) Testis germ hücreli tümörleri
E) Endometriyum karsinomu

9. Prenatal tanı yöntemleri ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Amniyosentez genellikle 15-20. gebelik haftaları arasında uygulanır.
II. Kordosentez fetal kan örneklemesi sağlar.
III. CVS en erken invaziv yöntemdir. (yeri tahmini)

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

10. Preimplantasyon genetik tanıda embriyonun kendisine dokunulmadan uygulanabilen ancak sadece maternal mayoz bölünme hatalarını yansıtabilen; paternal genetik katkıyı ve fetal cinsiyeti göstermeyen biyopsi tekniği hangisidir? (yeri tahmini)

A) Polar Body (Kutup Cisimciği) Biyopsisi
B) Gün 3 Blastomer Biyopsisi
C) Gün 5-6 Trofektoderm Biyopsisi
D) İç Hücre Kitlesi (ICM) Biyopsisi
E) Koryon Villus Biyopsisi (CVS)

Not: Grupta paylaşılan ekran görüntüsünde bu soru "Soru 3" olarak görünüyor; numarası kesin değil.

11. Başlangıçta normal gelişen bir yapının mekanik kuvvetlerin etkisiyle şeklinin veya konumunun değişmesine deformasyon denir. Aşağıdakilerden hangisi amniyotik bandın yaptığı mekanik basılardan kaynaklı oluşan deformasyona örnektir? (yeri tahmini)

A) Yarık dudak ve damak
B) Amniyotik bantlara bağlı ekstremite kaybı
C) Akondroplazi
D) Rahim içi basıya bağlı kraniyofasiyal şekil bozukluğu
E) Nöral tüpün kapanmamasına bağlı spina bifida

Not: Grupta 24.10 eklendi (TBG). Kök birebir değil, şıklar öğrencilerce doğrulandı. A ve E malformasyon, B disrupsiyon, C displazi.

12. Erken prenatal tanıda uygulanan koryon villus örneklemesinde (CVS) genetik analiz için alınan hücrelerin embriyolojik kökeni aşağıdakilerden hangisidir? (yeri tahmini)

A) Fetal amniyotik kavite epitel döküntüleri (amniyositler)
B) Koryon frondozum (trofoblastik villus hücreleri)
C) Fetal umbilikal kordon Wharton jölesi mezenkimi
D) Maternal uterin desidua bazalis hücreleri
E) Fetal karaciğer hematopoetik blast hücreleri

Not: Grupta tek öğrenci "böyle bir soru vardı" dedi; kök ve şıklar paylaşılan ekran görüntüsünden, kesin değil.

Enfeksiyon Hastalıkları · sınavda 13–34 · toplanan 19/22

13. Toxoplasma gondii enfeksiyonu ve korunma yolları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (yeri tahmini)

A) Seronegatif gebe kadınların ev kedisi ile temas etmemesi gerekir.
B) IgG avidite testi enfeksiyonun akut mu yoksa geçirilmiş mi olduğunu anlamada önemlidir.
C) Parazit insandan insana solunum yolu damlacıkları ile kolayca bulaşır.
D) Gebelikte geçirilen akut enfeksiyon fetüste hasar oluşturmaz.
E) Enfeksiyon kaynağı esas olarak kontamine süt ürünleridir.

14. Bakteriyel vajinozis tanısında kullanılan Amsel kriterleri düşünüldüğünde, aşağıdakilerden hangisi bu kriterler arasında yer almaz?

A) Vajinal pH değerinin > 4,5 olması
B) Direkt mikroskopide "clue cell" görülmesi
C) Whiff (amin) testinin pozitif olması (%10 KOH ile balık kokusu)
D) Direkt mikroskopide büyük büyütme alanında >10 lökosit/LÖA (PML) görülmesi
E) İnce, homojen gri-beyaz vajinal akıntı varlığı

15. Beta-laktam direnci ve antibiyotik tedavisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (yeri tahmini)

A) GSBL üreten suşlarda karbapenem grubu antibiyotikler tercih edilir.
B) MRSA enfeksiyonlarında vankomisin kullanılabilir.
C) GSBL üreten gram-negatif basiller 1. ve 2. kuşak sefalosporinlerle güvenle tedavi edilebilir.
D) Beta-laktamaz inhibitörleri (örn. klavulanik asit) enzimatik yıkımı engeller.
E) Pseudomonas enfeksiyonlarında antipseudomonal beta-laktamlar tercih edilmelidir.

16. Sağlıklı insanlarda steril olan ve normal florada mikroorganizma bulunmayan vücut bölgesi/sıvısı aşağıdakilerden hangisidir? (yeri tahmini)

A) Cilt yüzeyi
B) Kolon
C) Beyin omurilik sıvısı (BOS)
D) Ağız boşluğu
E) Dış üretra

Not: Grupta "Flora hangisinde bulunmaz? → BOS" olarak doğrulandı.

17. HBsAg pozitif olduğu bilinen bir hastanın kanı ile iğne batması sonucu temas eden ve daha önce hiç aşılanmamış bir sağlık çalışanına uygulanacak en uygun koruyucu profilaksi yaklaşımı hangisidir?

A) Sadece 1 doz hepatit B aşısı yapılması yeterlidir.
B) Yalnızca HBIG uygulanmalı, aşı yapılmamalıdır.
C) En kısa sürede hem HBIG hem de ilk doz hepatit B aşısı eş zamanlı yapılmalıdır.
D) 6 ay süreyle oral antiviral tedavi başlanmalıdır.
E) Sadece izlem yapılır, tedaviye gerek yoktur.

18. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan (CYBİ) korunmada bireysel ve toplumsal önlemler değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğrudan bir koruyucu önlem (birincil koruma) sayılmaz? (yeri tahmini)

A) Bariyer yöntemlerinin (kondom) kullanımı
B) Güvenli cinsel davranış bilincinin geliştirilmesi
C) CYBİ olan kişinin tanı alıp derhal tedavi edilmesi
D) Risk altındaki grupta hepatit B ve HPV aşılamaları
E) Cinsel partner sayısının sınırlandırılması

19. Genel hastane enfeksiyon kontrolü ve izolasyon önlemleri ile ilgili aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlıştır?

A) Sıçrama ihtimalinde önlük, eldiven, maske ve koruyucu gözlük takılmalıdır.
B) Temas izolasyonundaki odalara girerken önlük ve eldiven giyilmesi zorunludur.
C) Damlacık ve solunum yolu izolasyonundaki hastaların odasına girerken sadece kumaş hijyenik maske takılması yeterlidir.
D) Kontamine eller yıkanmadan başka hastaya temas edilmemelidir.
E) Kullanılmış enjektör iğneleri kesici-delici alet kutusuna atılmalıdır.

Not: Grupta bu soru "İzolasyon yöntemleriyle (standart önlemler) ilgili hangisi yanlıştır?" diye de hatırlandı; o sürümde yanlış şık "Sıçrama ihtimali olan işlemlerde önlük ve eldiven tek başına yeterlidir". Bir öğrenci damlacık izolasyonunda taşıma sırasında hastaya cerrahi maske takıldığını da hatırladı.

20. Aşağıdaki klinik tablolardan hangisi sekonder sifiliz evresinde görülen bulgulardan biri değildir?

A) Tabes dorsalis
B) El ve ayak tabanında makülopapüler döküntüler
C) Kondiloma lata
D) Yaygın lenfadenopati
E) Asemptomatik hepatit

21. Sifiliz hastalığı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (yeri tahmini)

A) Birincil evrede görülen şankr tipik olarak ağrılı bir ülserdir.
B) Tedavide birinci basamak seçenek benzatin penisilin G'dir.
C) Latent evrede hastada belirgin bir klinik bulgu izlenmez.
D) Etkeni bir spiroket olan Treponema pallidum'dur.
E) Üçüncül evrede gommalar ve kardiyovasküler tutulumlar izlenebilir.

Not: Bir öğrenci soruyu öncüllü hatırladı: "latent sifiliz...", "primer evrede şankr ağrılıdır", "kondiloma lata..." öncülleri vardı, diğer ikisi hatırlanmadı.

22. Klinik pratikte akılcı antibiyotik kullanımı ilkelerine göre doğru antibiyotik seçimi ve kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Muhtemel mikroorganizmanın antimikrobiyal duyarlılık durumu bilinmelidir.
B) Kullanılacak antibiyotiğin PK/PD özellikleri bilinmelidir.
C) Enfeksiyon nedeni olan mikroorganizma bilinmeli veya tahmin edilmelidir.
D) Ateşi yüksek olan her hastaya odak bulunamasa dahi derhal geniş spektrumlu antibiyotik başlanmalıdır.
E) İlacın organ toksisitesi değerlendirilmelidir.

23. HBsAg pozitif fakat aşı yapılmamış bir anneden doğan bebeğe doğumdan hemen sonra uygulanacak doğru yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalnızca hepatit B aşısı yapılması yeterlidir.
B) Tedavi vermeye gerek yoktur, 1. ayda kontrol testleri yapılır.
C) Yalnızca hepatit B immünglobulin (HBIG) verilmelidir.
D) Bebek ilk 6 ay doğrudan antiviral oral tedaviye alınır.
E) Doğumdan sonraki ilk 12 saat içinde hepatit B aşısı ve HBIG birlikte yapılmalıdır.

24. Febril nötropenik bir hastada geniş spektrumlu antibiyotik tedavisine rağmen ateşin 72 saat boyunca düşmemesi ve odağın bulunamaması durumunda en uygun yaklaşım ne olmalıdır? (yeri tahmini)

A) Mevcut antibiyotik tedavisi kesilip hasta takibe alınmalıdır.
B) Empirik sistemik antifungal tedavi eklenmelidir.
C) Yalnızca ateş düşürücü verilerek 48 saat beklenmelidir.
D) Antibiyotik dozu yarıya indirilmelidir.
E) Oral antiviraller başlanıp taburcu edilmelidir.

25. Gonokoksik üretrit ve komplike olmayan gonore tedavisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Chlamydia enfeksiyonu riski nedeniyle kombinasyon tedavisi tercih edilebilir.
B) Enfekte hastanın cinsel partnerinin tedavisine gerek yoktur.
C) Kinolon grubu antibiyotiklere yüksek direnç oranları bildirilebilmektedir.
D) Tek doz azitromisin veya doksisiklin tedaviye eklenebilir.
E) Tek doz IM seftriakson tedavisi önerilen birinci basamak seçeneklerdendir.

26. Akut prostatit tanısı ve yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (yeri tahmini)

A) Şiddetli bakteriyemi/sepsis riski nedeniyle sert rektal muayene ve prostat masajından kaçınılmalıdır.
B) Tedavide penisilin V ilk seçenektir.
C) Hastalarda idrar yapma zorluğu ve ateş hiçbir zaman izlenmez.
D) Tanı için prostat biyopsisi rutin olarak uygulanmalıdır.
E) Yalnızca cerrahi olarak prostatın çıkarılmasıyla iyileşir.

27. Gebelikte Toxoplasma gondii enfeksiyonu, tanısı ve korunma önlemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (yeri tahmini)

A) Anti-Toxoplasma IgM pozitifliği akut primer enfeksiyon tanısı için her zaman yeterlidir.
B) Gebenin kediyle temas etmemesi, çiğ et yememesi korunmada önemlidir.
C) IgG avidite testinde yüksek avidite saptanması, enfeksiyonun son 3-4 ay içinde geçirildiğini gösterir.
D) Gebeliğin son aylarında fetüse bulaşma riski azalır.
E) Konjenital toksoplazmozis riski ilk trimesterde en düşük orandadır.

28. toplanmadı

29. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bir prion hastalığı değildir?
A) Creutzfeldt-Jakob hastalığı (CJD)
B) Kuru
C) Bulaşıcı süngerimsi beyin hastalığı (BSE)
D) Fatal familial insomnia
E) Alzheimer hastalığı
Not: Grupta hatırlanan şıklar: Creutzfeldt-Jakob, kuru, deli dana hastalığı, ailesel ölümcül uykusuzluk.

30. toplanmadı

31. Üriner sistem enfeksiyonları (ÜSE) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Toplum kaynaklı komplike olmayan ÜSE'de en sık etken E. coli'dir ve çoğunlukla asendan yolla bulaşır.
B) Böbreğe ulaşan enfeksiyonlar her zaman hematojen yolla yayılır.
C) Semptomsuz olan tüm hastalara antibiyotik başlanmalıdır.
D) Üreaz pozitif bakteriler idrar pH'sını asidifiye eder.
E) İdrarda tek bir lökosit görülmesi kesin piyelonefrit tanısı koydurur.

32. 28 yaşında kadın hasta 2 gündür yanma, ateş, sağ yan ağrısı ile başvuruyor. Fizik muayenede ateş 38,8 °C, sağ KVAH+ saptanıyor. Piyüri ve nitrit pozitif. Piyelonefrit tablosunda doku penetrasyonu yetersizliği nedeniyle tercih edilmeyen antibiyotik hangisidir?
A) Siprofloksasin
B) Seftriakson
C) Fosfomisin (tek doz)
D) Trimetoprim-sulfametoksazol
E) Levofloksasin
Not: E şıkkı grupta levofloksasin olarak düzeltildi (iki öğrenci).

33. Hücresel immün yetmezliği (T lenfosit defekti) olan bir bireyde aşağıdaki fırsatçı mikroorganizmalardan hangisine bağlı enfeksiyon gelişme riski belirgin şekilde artar?
A) Streptococcus pneumoniae
B) Haemophilus influenzae
C) Toxoplasma gondii
D) Neisseria meningitidis
E) Streptococcus pyogenes

34. toplanmadı

Patoloji · sınavda 35–68 · toplanan 31/34

35. Oil Red O ile nötral lipitleri güvenle göstermek için uygun yaklaşım hangisidir?
A) Doku rutin formalin tespiti sonrası parafine gömülmelidir.
B) Taze/dondurulmuş (frozen) kesit alınıp tespit işlemi ksilol kullanılmadan yapılmalıdır.
C) Dokular alkol serilerinden geçirilip dehidrate edilmelidir.
D) Yüksek ısıda otoklavlanmalıdır.
Not: Şık eksik: 4 şık toplandı. Grupta "dondurulmuş kesit soru kökünde değil şıktaydı ve cevap oydu", "parafinle ilgili 3 şık ve gümüş boyama vardı" denildi.

36. Dokularda gelişen nekroz tipleri ve organ eşleşmeleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi en tipik patognomonik/karakteristik eşleşmedir?
A) Beyin enfarktı - likefaksiyon nekrozu; Kalp enfarktı - koagülatif nekroz
B) Akciğer enfarktı - fibrinoid nekroz; Karaciğer - yağ nekrozu
C) Beyin enfarktı - koagülatif nekroz; Dalak - gangrenöz nekroz
D) Mide enfarktı - kazeöz nekroz; Böbrek - likefaksiyon nekrozu
E) Pankreas - koagülatif nekroz; Beyin - kazeöz nekroz

37. Hücrede ROS artışı kronikleşirse hangi iki süreç öne çıkar?
Şıklar toplanmadı. Hatırlanan cevap: DNA hasarı ile kanser; protein ve lipit hasarı ile hücre yaşlanması
Not: Kısmi: yalnız doğru şık (C) hatırlandı, diğer şıklar toplanmadı.

38. Patolojik hiperplazi ve neoplazi süreçleri arasındaki ilişki için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Hiperplazide uyarı kesilse dahi hücre çoğalması kontrolsüz devam eder.
B) Hiperplazi fizyolojik/patolojik uyaranla gelişir; uyarı kesilince büyüme durabilir ancak patolojik hiperplazi neoplaziye zemin hazırlayabilir.
C) Neoplazi tamamen geri dönüşümlü bir süreçtir.
D) Hiperplazi sadece malign tümörlerde görülür.
E) Hiperplazide hücre sayısı sabit kalır.

39. Kanser hücrelerinde telomeraz enziminin reaktivasyonu ve yüksek aktivitesinin temel patogenetik önemi nedir?
A) Hücrenin apoptoza girmesini doğrudan tetikler.
B) Hayflick sınırının aşılmasını sağlar, telomer boyunu koruyarak hücreye sonsuz bölünme yeteneği kazandırır.
C) DNA replikasyonunu tamamen durdurur.
D) Hücre dışı matris yıkımını engeller.
E) Tümör hücresinin immün sistem tarafından tanınmasını sağlar.

40. Fibrinöz perikarditte çözünmeyen (temizlenemeyen) fibrin için beklenen sonuç nedir?
Şıklar toplanmadı.
Not: Kısmi: şıklar toplanmadı. Beklenen bilgi: fibrin temizlenemezse organizasyon (fibrozis) ile skar ve yapışıklık gelişir.

41. Komplement sisteminin alternatif ve lektin yolu için doğru tetikleyici çifti hangisidir?
Şıklar toplanmadı.
Not: Kısmi: şıklar toplanmadı. Beklenen bilgi: alternatif yol mikrobiyal yüzey bileşenleri (ör. LPS, endotoksin) ile, lektin yolu mannoz bağlayan lektinin mikrobiyal mannoza bağlanmasıyla başlar.

42. Kronik enflamasyonun morfolojik özellikleri için en doğru kombinasyon hangisidir?
Şıklar toplanmadı. Hatırlanan cevap: Mononükleer hücre infiltrasyonu + doku yıkımı + onarım (anjiyogenez, fibrozis)
Not: Kısmi: yalnız doğru şık hatırlandı.

43. Sekonder yara iyileşmesinde en tipik özellik nedir?
Şıklar toplanmadı.
Not: Kısmi: bir şık "az skar..." diye başlıyordu. Sekonder iyileşmede tipik olan daha fazla granülasyon dokusu, belirgin skar ve miyofibroblastlarla yara kontraksiyonudur; "az skar" bu nedenle çeldirici olabilir.

44. Kronik pulmoner konjesyonda en olası histolojik kombinasyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alveol septasında incelme + lenfatik genişleme
B) Alveol septasında fibrozis + hemosiderin makrofajı
C) Bronşiolde metaplazi + kazeifikasyon
D) Kapiller damarda trombus + koagülasyon nekrozu
E) Yaygın amiloid birikim + granülom oluşumu

45. Ülserleşmiş aterosklerotik plak üzerinde gelişen arteriyel tromboz için Virchow üçlüsünün en uygun bileşenleri hangisidir?
Şıklar toplanmadı.
Not: Kısmi: hatırlanan şıklar "staz + laminar akım", "anormal kan akımı + ...", "hiperkoagülabilite, endotel hasarı + staz". Beklenen cevap: endotel hasarı + anormal (türbülanslı) kan akımı.

46. Septik şok seyrinde adrenal yetmezlik gelişmesi hangi sendrom ile ilişkilendirilir?
A) Waterhouse-Friderichsen sendromu
B) Goodpasture sendromu
C) Cushing sendromu
D) Conn sendromu
E) Addison hastalığı

47. Tip IV (gecikmiş tip) aşırı duyarlılık reaksiyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi en doğrudur?
A) Dolaşan immün komplekslerin dokularda birikmesiyle gelişir.
B) Mast hücreleri ve IgE antikorları aracılığıyla gelişir.
C) T lenfositler (CD4+ ve CD8+) aracılıdır, antikorların doğrudan rolü yoktur veya azdır.
D) Sadece IgG veya IgM sınıfı antikorlar rol oynar.
E) Komplement sisteminin doğrudan aktivasyonu ile saniyeler içinde gelişir.
Not: E şıkkı grupta hatırlanmadı. Grupta "lineer IgG iki soruda da şık olarak geçiyordu" denildi.

48. Marfan sendromlu hastalarda doku elastik lif yapısındaki bozukluğa bağlı olarak en sık görülen ve hayati tehdit oluşturan kardiyovasküler komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pulmoner kapak stenozu
B) Mitral kapak kalsifikasyonu
C) Triküspit yetmezliği
D) Koroner arter aterosklerozu
E) Aort anevrizması ve aort diseksiyonu

49. Kurşun maruziyeti olan erişkinlerde en tipik nörolojik bulgu hangisidir?
Şıklar toplanmadı.
Not: Kısmi: şıklarda çocuk bulguları (ensefalopati) ile erişkin bulguları ayrı şıklardaydı, 3 şık da çeldiriciydi. Beklenen cevap: erişkinde periferik (motor) nöropati, el/ayak bileği düşmesi.

50. Diyabetik nefropatinin patognomonik ve en karakterize histopatolojik nodüler glomerüler nodül bulgusu aşağıdakilerden hangisidir? (yeri tahmini)
A) Kimmelstiel-Wilson nodülleri
B) Libman-Sacks lezyonları
C) Flea-bitten böbrek
D) Wire-loop lezyonu
E) Crescentic glomerülorefleks

51. Aşağıdaki klinik tümör kümelenmelerinden hangisi Li-Fraumeni sendromu (TP53 mutasyonu) ile en uyumludur?
A) Yumuşak doku sarkomu, osteosarkom, meme kanseri, beyin tümörleri ve adrenokortikal karsinom
B) Medüller tiroid karsinomu, feokromositoma, paratiroid hiperplazisi
C) Kolon polipleri, osteomlar, epidermoid kistler
D) Renal hücreli karsinom, hemanjiyoblastom, feokromositoma
E) Bilateral akustik nörinom, meningiom, şvannom

52. SLE nedeniyle uzun süreli hidroksiklorokin (Plaquenil) kullanan bir hastanın organ toksisitesi takibinde rutin olarak hangi muayenenin yapılması gereklidir? (yeri tahmini)
A) Oftalmolojik (göz dibi / retina) muayene
B) Odyolojik muayene
C) Açık akciğer biyopsisi
D) Kemik iliği aspirasyonu
E) Günlük troponin ölçümü
Not: Şıklar gruptaki öğrenci sürümüne göre düzeltildi (birkaçından emin değiller).

53. Apoptoz (programlanmış hücre ölümü) mekanizması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (yeri tahmini)
A) Hücre büzülmesi ve kromatin kondansasyonu izlenir.
B) Hücre zarı bütünlüğü korunur, belirgin inflamasyon oluşturmaz.
C) Ana yürütücü (executioner) kaspaz kaspaz-3'tür; kaspaz-8 ve 9 ise başlatıcıdır.
D) DNA 180-200 bp oligonükleozomal fragmanlara bölünür.
E) BCL-2 ailesi proteinleri apoptoz regülasyonunda rol almaz.

54. Minimal Değişim Hastalığı (Minimal Change Disease) patolojisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Proksimal tübülde kresent birikimi
B) Proksimal tübülde kalsifikasyon birikimi
C) Proksimal tübülde protein damlacıkları ve lipit birikimi
D) Proksimal tübülde IgG birikimi
E) Çizgisel (lineer) IgG birikimi
Not: Şıklar gruptaki öğrenci sürümüne göre düzeltildi; E şıkkı kısmen hatırlandı.

55. Aşağıdakilerden hangisi nefritik sendrom klinik tablosunun tipik bulgularından biridir? (yeri tahmini)
A) Masif proteinüri (>3,5 g/gün) ve belirgin lipidüri
B) İzole hiperlipidemi ve ksantomlar
C) İzole glukozüri ve ketonüri
D) Hematüri, oligüri, hipertansiyon ve eritrosit silendirleri
E) İzole hipokalsemi ve tetani

56. İntrasellüler ROS artışı ve DNA hasarında apoptozun mitokondriyal (intrinsik) yolağında gerçekleşen olayların doğru sırası hangisidir? (yeri tahmini)
A) Sitokrom-c salınımı → BAX/BAK aktivasyonu → Kaspaz-3
B) BAX/BAK oligomerizasyonu → zar geçirgenlik artışı → sitokrom-c'nin sitozole salınımı → kaspaz aktivasyonu
C) Kaspaz-3 aktivasyonu → sitokrom-c → DNA kırılması
D) TNF reseptör bağlanması → kaspaz-8 → BAX baskılanması
E) Bcl-2 artışı → mitokondri patlaması → nekroz

57. Akut piyelonefrit tanısında böbrek histopatolojisinde görülen en tipik mikroskobik bulgu nedir?
A) Tübüluslarda ve interstisyel alanda nötrofil lökosit infiltrasyonu ile tübüler nekroz ve lökosit silendirleri
B) Glomerüllerde mezanjiyal amiloid birikimi
C) Bowman kapsülünde kresent oluşumu
D) Arteriyollerde hiyalin kalınlaşma
E) İnterstisyel alanda yoğun eozinofil birikimi

58. Endokrin organ tümörlerinde hormon üretimi ve fonksiyonel aktivite ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (yeri tahmini)
A) Malign ve anaplastik tümörler her zaman en yüksek hormonu salgılar.
B) İyi diferansiye benign tümörlerde hormon üretimi ve salgılanması normal endokrin yapıya daha uygundur.
C) Tümörün diferansiyasyonu düştükçe hormon sentez kapasitesi artar.
D) Adenomlar hiçbir zaman hormon salgılayamaz.
E) Hormon üretimi sadece metastatik lezyonlarda gerçekleşir.

59. Renal hücreli karsinomun (RCC) en sık görülen 3 histolojik/moleküler alt tipi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Onkositoma, Wilms, anjiyomiyolipom
B) Berrak hücreli (clear cell), papiller, kromofob
C) Papiller, Wilms, kromofob
D) Berrak hücreli, onkositoma, kromofob
E) Kromofob, anjiyomiyolipom, berrak hücreli

60. Genital Herpes Simplex Virüs (HSV) enfeksiyonunun doku histopatolojisindeki en tipik sitopatolojik bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dokuda koilositoz ve belirgin perinükleer halo
B) Cowdry A tipi intranükleer inklüzyonlar, multinükleasyon ve nükleer marjinasyon
C) Obliteratif/proliferatif endarterit
D) Nekrotizan granülom ile oluşan yıldızsı apse
E) Lamina propria içinde lenfoid folikül

61. Candida vulvovajiniti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tipik olarak kaşıntı ve peynirimsi beyaz akıntı ile seyreder.
B) Cinsel yolla bulaşan bir hastalık olarak sınıflandırılmaz; fırsatçıdır.
C) Antibiyotik kullanımı ve diyabet riski artırır.
D) Mikroskopide psödohif ve tomurcuklanan maya hücreleri izlenebilir.
E) Bulaşması esas olarak siprofloksasin kullanımı ile tamamen engellenir.
Not: Grupta şıklarda hem "cinsel yolla bulaşır" hem "cinsel yolla bulaşmaz" ifadesi olduğu hatırlandı; diğer şıklar kesin değil.

62. toplanmadı

63. Endometriyum hiperplazisini en iyi tanımlayan sınıflama aşağıdakilerden hangisidir?
A) LSIL / HSIL
B) Seröz / berrak hücreli
C) Atipili / atipisiz
D) Kronik / akut
E) Papiller / kromofob
Not: Şıklar gruptaki öğrenci sürümünden.

64. Müsinöz over tümörleri ve Krukenberg tümörü ile ilgili soru (kök ve şıklar toplanmadı).
Şıklar toplanmadı.
Not: Kısmi: grupta yalnız 64. soru için ders slaytı paylaşıldı. Ana bilgi: müsinöz over tümörlerinin bilateral olma olasılığı düşüktür; Krukenberg tümörü GİS kökenli metastatik müsinöz adenokarsinomdur ve sıklıkla bilateraldir.

65. toplanmadı

66. toplanmadı

67. Aşağıdakilerden hangisi meme başının Paget hastalığı için doğrudur?
Şıklar toplanmadı.
Not: Kısmi: şıklar toplanmadı. Grupta hatırlanan doğru ifade: "Altında sıklıkla DCIS veya invaziv meme karsinomu bulunur."

68. Prostat adenokarsinomunu histolojik olarak BPH veya benign bezlerden ayıran en önemli histopatolojik özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Prostat bezlerindeki dış bazal hücre (miyoepitelyal) tabakasının kaybolması
B) Bezlerde korpora amilasea bulunması
C) Stromada lenfosit birikimi
D) Bez boyutlarının aşırı büyümeli olması
E) Bezlerin tek katlı silindirik epitelle döşeli olması

Halk Sağlığı · sınavda 69–78 · toplanan 9/10

69. Anne sütü ve bebek beslenmesi ile ilgili öncüllerden hangileri doğrudur?
I. İlk 6 ayda besin gereksiniminin %90'ını karşılar.
II. TÜİK 2025 verilerine göre Türkiye'de toplam doğurganlık hızı 1,42'dir.
III. Anne sütündeki demirin emilimi %50'dir.
IV. (hatırlanmadı)
Şıklar toplanmadı.
Not: Kısmi: öncüller gruptaki tartışmadan (öğrenciler "%90", "1,42", "demir emilimi %50" konusunda anlaştı; dördüncü öncül ve şıklar hatırlanmadı). Derleme PDF'indeki "%100 / demir-kalsiyum / D vitamini" sürümü öğrencilerce düzeltildi.

70. Türkiye'de çağdaş halk sağlığı biliminin kurucusu kabul edilen, 224 Sayılı Sosyalleştirme Kanunu'nu hazırlayan bilim insanı kimdir? (yeri tahmini)
A) Prof. Dr. Nusret Fişek
B) Dr. Refik Saydam
C) Dr. Behçet Uz
D) Prof. Dr. Mazhar Osman
E) Dr. Hulusi Behçet

71. Bulaşıcı hastalıkların ve çevresel toplum sağlığı risklerinin önlenmesinde hangisi çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetidir? (yeri tahmini)
A) Besin kontrolü / beslenme değişikliği
B) Kemoprofilaksi
C) Bağışıklama
D) Hijyen
E) Sağlık eğitimi
Not: Şıklar gruptaki öğrenci sürümüne göre düzeltildi. Cevap tartışmalı: grupta "hijyen mi?" diye soruldu, kesinleşmedi. Bağışıklama ve kemoprofilaksi kişiye yönelik hizmetlerdir.

72. Gebelik takibinde tüm gebelere rutin önerilen ve gebelikte güvenle uygulanabilen aşı aşağıdakilerden hangisidir? (yeri tahmini)
A) Kızamıkçık (rubella) aşısı
B) Suçiçeği aşısı
C) Tetanoz (Td/Tdap) aşısı
D) Kızamık aşısı
E) BCG (verem) aşısı

73. Aşağıdakilerden hangileri sekonder korunma yöntemidir?
I. Halk sağlığı merkezlerinde verilen hijyen eğitimi
II. Mamografi
III. Bir ailenin çocuklarının ne zaman doğacağını planlaması
IV. Pap smear (yeri tahmini)
A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve IV
D) Yalnız IV
E) III ve IV
Not: Grupta 24.10 eklendi. II. öncülün mamografi mi bağışıklama mı olduğu tartışıldı, çoğunluk mamografi dedi. Kökün "yöntemidir" olduğu hatırlandı.

74. Terminde ve 2,5 kg doğan bebeğin 6. ay ve 1. yaştaki beklenen ortalama ağırlıkları hangisinde doğru verilmiştir?
A) 6. ay: 3,5 kg / 1. yaş: 5 kg
B) 6. ay: 5 kg / 1. yaş: 7,5 kg
C) 6. ay: 7,5 kg / 1. yaş: 10 kg
D) 6. ay: 9 kg / 1. yaş: 12 kg
E) 6. ay: 4 kg / 1. yaş: 6 kg
Not: Derleme PDF'inin anahtarı C diyor; grupta da paylaşılan ders notuna göre bebekler 4–6 ayda doğum ağırlığının 2, bir yaşında 3 katına ulaşır → B (5 / 7,5 kg).

75. Koruma düzeyleri ile ilgili öncüllü ikinci soru (öncüllerden hangileri doğrudur). (yeri tahmini)
Şıklar toplanmadı.
Not: Kısmi: grupta hatırlanan öncüller "istediği zaman çocuk sahibi olmak için aile planlaması yapan çift tersiyer korumadır", "okullarda yapılan göz taraması sekonder korumadır" ve "... primer korumadır"; şıklar toplanmadı.

76. Gebe izlemi: sağlıklı bir gebe gebelik boyunca en az kaç kez izlenmelidir? (yeri tahmini)
Şıklar toplanmadı. Hatırlanan cevap: 4
Not: Kısmi: grupta tek öğrenci "cevap 4" diye hatırladı; şıklar toplanmadı.

77. toplanmadı

78. Anne sütünde bulunmayan bileşen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alfa-laktalbümin
B) Laktoferrin
C) Beta-laktoglobulin
D) Sekretuar IgA
E) Kazein

Üroloji · sınavda 79–90 · toplanan 11/12

79. Akut komplike olmayan sistit vakalarında aşağıdaki klinik bulgulardan hangisinin görülmesi beklenmez? (yeri tahmini)
A) Dizüri (idrar yaparken yanma)
B) Pollaküri (sık idrara çıkma)
C) Yüksek ateş ve titreme
D) Sıkışma (urgency) hissi
E) Suprapubik ağrı

80. Enürezis nokturnası olan 7 yaşında erkek çocukta birinci basamak medikal tedavi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bekle-gör yaklaşımı
B) Üroterapi
C) Desmopressin
D) Antidepresan
E) Antikolinerjik
Not: Kök ve şıklar gruptaki öğrenci sürümüne göre düzeltildi ("davranışsal tedaviye yanıt yok" ifadesi kökte yoktu).

81. Aşağıdaki patolojik durumlardan hangisi prerenal proteinüri (overflow/taşma proteinürisi) nedenleri arasında yer alır?
A) Glomerülonefrit
B) Multipl miyelom (Bence-Jones proteinürisi)
C) Diyabetik nefropati
D) Polikistik böbrek hastalığı
E) Alt üriner sistem enfeksiyonu
Not: Grupta şıklar "gebelik, glomerülonefrit, nefritik sendrom..." diye de hatırlandı; şıklar kesin değil.

82. Aşağıdakilerden hangisi üriner sistem taş hastalığı (ürolitiyazis) gelişiminde bir risk faktörü değildir? (yeri tahmini)
A) Yetersiz (az) sıvı alımı
B) Hiperkalsiüri
C) Yüksek oranda hayvansal protein ve tuz tüketimi
D) Yeterli su tüketimi
E) Sıcak iklimde yaşamak

83. Suprapubik aspirasyon ile elde edilen idrar kültüründe anlamlı enfeksiyon tanısı için en az kaç CFU/mL bakteri yeterlidir? (yeri tahmini)

A) 10^5
B) 10^4
C) 10^3
D) 10^7
E) 10^6

Not: Tartışmalı: ders slaytında suprapubik aspirasyonda "herhangi bir sayıda gram(-) basil, ≥10^3 gram(+) kok" yazıyor; bir öğrenci "bakteri bulunması anlamlıdır" diye itiraz önerdi.

84. Enürezis nokturna için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (yeri tahmini)

A) 3 yaşın üzerindeki çocuklar tedavi gerektirir.
B) Yıllık spontan rezolüsyon oranı yaklaşık %15'tir.
C) Hastalığın patogenezinde genetik de yer alır.
D) Uyanma güçlüğü sıklıkla eşlik eder.
E) Enürezis sıklığı arttıkça spontan rezolüsyon oranı azalır.

Not: Grupta 24.10 eklendi; tedavi 5 yaşından sonra düşünülür. Şıklardan emin değiller.

85. Aşağıdaki obstrüktif üropati nedenlerinden hangisi infravezikal (mesane altı) obstrüksiyon nedenidir?

A) Renal kist
B) Posterior üretral valv (PUV)
C) Gebeliğe bağlı üretere bası
D) Nefrolitiyazis
E) Renal arter anevrizması

Not: Bir öğrenci D şıkkını "fimozis" olarak hatırladı; öyleyse o da infravezikaldir, şıklar kesin değil.

86. Alt üriner sistem obstrüksiyonlarında mesanenin kompansasyon evresi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Detrüsör kası hipertrofiye uğrar ve işeme basıncını artırarak mesanede rezidüel idrar kalmamasını sağlar.
B) Mesane kası tamamen atoniktir.
C) İşeme sonrası yüksek miktarda glob vezikale oluşur.
D) Böbrek yetmezliği hemen gelişir.
E) Detrüsör kası incelir ve atrofiye uğrar.

87. İdrar örneği alma yöntemleri değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Orta akım idrarı rutin kültür için en sık kullanılan yöntemdir.
B) Suprapubik aspirasyon kontaminasyona en açık ve güvenilmez idrar alma yöntemidir.
C) Sondalı hastalarda idrar kateterin özel steril portundan alınmalıdır.
D) Bebeklerde idrar torbası örneklerinde üremede konfirmasyon gerekebilir.
E) Suprapubik aspirasyon invaziv bir yöntemdir.

88. Üriner sistem enfeksiyonlarının tanımları ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Rekürren enfeksiyonlar, iyi bir tedavinin ardından genellikle iki haftadan az sürede aynı patojenle gerçekleşen üriner sistem enfeksiyonlarıdır.
B) Re-enfeksiyon, geçirilmiş bir enfeksiyonun ardından farklı bir patojenle tekrar enfekte olmaktır.
C) Bakteriyel persistans, üriner sistemde yerleşmiş patojenlerin yaptığı rekürren enfeksiyonlardır.
D) Nozokomiyal (hastane kaynaklı) enfeksiyonlar tipik olarak Pseudomonas veya dirençli suşların yaptığı enfeksiyonlardır.
E) Anatomik ya da yapısal anomalisi bulunmayan hastalardaki üriner sistem enfeksiyonlarına komplike üriner sistem enfeksiyonu denir.

Not: Beş şık gruptaki öğrenci sürümünden. E kesin yanlış (bu tanım komplike olmayan ÜSE'dir). Derleme PDF'i A'yı işaretlemişti; A aslında relapsın tanımıdır, tartışmalı.

89. Aşağıdakilerden hangisi alt üriner sistemin depolama (dolum) semptom veya fonksiyonlarından biri değildir?

A) Noktüri
B) Sıkışma
C) Aralıklı akım
D) Pollaküri
E) Sıkışma tipi idrar kaçırma

90. toplanmadı

Kadın Hastalıkları ve Doğum · sınavda 91–96 · toplanan 6/6

91. G2P1 gebede USG'de serviks açık, intrauterin servikse yakın yerleşimli, düzensiz görünümde gestasyonel kese izlenirken embriyo/kalp atımı izlenmiyor. Kanama ve krampları olan bu hastada en olası düşük tanısı nedir?

A) Abortus imminens (düşük tehdidi)
B) Komplet abortus
C) İnkomplet abortus (tam olmayan düşük)
D) Tekrarlayan gebelik kaybı
E) Missed abortus

92. Aşağıdakilerden hangisi gebelikte fetal kromozom anomalilerinin kesin tanısı amacıyla uygulanan invaziv (girişimsel) testlerden biridir? (yeri tahmini)

A) İkili tarama testi
B) Üçlü tarama testi
C) Koryon villus biyopsisi (CVS)
D) Entegre tarama testi
E) Ultrasonografik ense kalınlığı (NT) ölçümü

Not: Grupta 24.10 eklendi. Kökün "biridir" olduğu hatırlandı; dörtlü test şıklarda yoktu, entegre test vardı, CVS ya da kordosentez şıklardaydı.

93. Toplam 4 kez gebe kalmış, 36. ve 38. haftalarda 2 canlı çocuk doğurmuş (biri vajinal, biri sezaryen), 16. ve 25. haftalarda 2 kez düşük yapmış kadının G P Y A değeri nedir?

A) G4 P2 Y2 A2
B) G4 P4 Y2 A0
C) G2 P2 Y2 A2
D) G4 P3 Y2 A1
E) G3 P2 Y1 A1

Not: 20. haftayı geçen 25. hafta kaybı doğum (parite) sayılır, 16. hafta kaybı abortus.

94. Perinatolojide fetal iyilik halinin değerlendirilmesinde kullanılan aşağıdaki testlerden hangisi bir fetal iyilik hali değerlendirme testi değildir?

A) Non-stres test (NST)
B) Biyofizik profil (BPP)
C) Kontraksiyon stres testi (CST)
D) Fetal umbilikal arter Doppler ultrasonografi
E) Doppler ile fetal renal arter incelemesi

Not: Grupta cevap "Doppler ile renal arter incelemesi" olarak hatırlandı; şıkların geri kalanı kesin değil. Derleme PDF'inde E "maternal serum AFP" idi.

95. Düşükle ilgili öncüllü/ifadeli soru: aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (yeri tahmini)

Şıklar toplanmadı.

Not: Kısmi: grupta hatırlanan ifadeler "düşük doz radyasyon düşüğe neden olur" ve "en sık abort nedeni trizomi 21"; şıklar ve cevap toplanmadı.

96. Grafik/tablo üzerinden sorulan fetal izlem sorusu. (yeri tahmini)

Şıklar toplanmadı.

Not: Kısmi: grupta "kadın doğumdaki grafik sorusuna itiraz edecek miyiz" diye konuşuldu, cevap için "non-stres test" denildi; kök ve şıklar toplanmadı.

Farmakoloji · sınavda 97–100 · toplanan 3/4

97. Böbrek nakli yapılan hastada T lenfosit aktivasyonunu baskılamak için başlanan takrolimusun temel etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

A) mTOR proteinini inhibe ederek IL-2 yanıtını engellemek
B) Dihidrofolat redüktazı inhibe ederek DNA sentezini bozmak
C) Kalsinörini inhibe ederek IL-2 gen transkripsiyonunu engellemek
D) IL-2 reseptörünün alfa alt birimini (CD25) bloke etmek
E) İnozin monofosfat dehidrojenaz enzimini inhibe etmek

98. Gebelerde kullanımı sırasında ağır teratojenite (fokomeli / ekstremite yokluğu) yol açtığı için gebelikte kullanımı kesinlikle kontrendike olan tarihî ilaç hangisidir? (yeri tahmini)

A) Talidomid
B) Penisilin
C) Parasetamol
D) Folik asit
E) İnsülin

99. toplanmadı

100. Kemik rezorpsiyonunu engellemek amacıyla kullanılan, RANKL'a karşı geliştirilmiş monoklonal antikor ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Denosumab
B) Siklosporin
C) Metotreksat
D) İnfliksimab
E) Bevasizumab

Cevap anahtarı (tahmini numaralarla)

No	Cevap	No	Cevap	No	Cevap	No	Cevap
1	D	26	A	51	A	76	kısmi*
2	A	27	B	52	A	77	—
3	D	28	—	53	E	78	C
4	D	29	E	54	C	79	C
5	A	30	—	55	D	80	C
6	B	31	A	56	B	81	B
7	A	32	C	57	A	82	D
8	D	33	C	58	B	83	C
9	E	34	—	59	B	84	A
10	A	35	B	60	B	85	B
11	D	36	A	61	E	86	A
12	B	37	kısmi*	62	—	87	B
13	B	38	B	63	C	88	E
14	D	39	B	64	kısmi	89	C
15	C	40	kısmi	65	—	90	—
16	C	41	kısmi	66	—	91	C
17	C	42	kısmi*	67	kısmi	92	C
18	C	43	kısmi	68	A	93	D
19	C	44	B	69	kısmi	94	E
20	A	45	kısmi	70	A	95	kısmi
21	A	46	A	71	D	96	kısmi
22	D	47	C	72	C	97	C
23	E	48	E	73	C	98	A
24	B	49	kısmi	74	B	99	—
25	B	50	A	75	kısmi	100	A

Toplanan: 91/100 (kısmi olanlar dahil) · Toplanmayan: 9 · kısmi* = şıklar yok, doğru cevap metinde